

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5096881-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: FILIPE NAVARRO BRASIL

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DA DIABETES. ENTREGA DO MONITOR FREESTYLE LIBRE DA ABBOTT (3 SENSORES POR MÊS). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5096881-42.2024.4.02.5101

510015259500 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5096881-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: FILIPE NAVARRO BRASIL

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar, interposta pela parte autora, em face de decisão que deferiu a tutela antecipada para o tratamento da diabetes da parte autora, porém, não da forma como a parte autora almejada, deixando de determinar a entrega do monitor FREESTYLE LIBRE DA ABBOTT (3 sensores por mês), por tempo indeterminado.

O juízo de origem deferiu a tutela para tratamento da parte autora nos seguintes termos:

Trata-se de ação movida por FILIPE NAVARRO BRASIL, em face da UNIÃO FEDERAL, do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, na qual pretende, inclusive em sede de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento Insulina Tresiba (3 canetas por mês) e dos insumos Monitor Freestyle Libre e Sensor de Freestyle Libre (3 sensores por mês).

A parte autora relata ser portador de diabetes Mellitus - Tipo 1, desde os 18 anos, com grande variabilidade glicêmica. Mesmo tendo utilizado as terapias fornecidas pelo SUS, não conseguiu controlar sua doença.

Alega que atualmente utiliza a insulina NPH, insumo padronizado na lista do SUS, contudo sem alcançar o resultado desejado pelo seu médico. Em Evento 1, LAUDO10, a Dra. Ana Paula Brilhante (Endocrinologista - CRM 5266782-0) informa "já ter feito vários esquemas com a insulina fornecida pelo SUS (NPH) e não ter conseguido o controle de sua glicemia(...)."

A fim de demonstrar a tentativa de tratamento com a insulina NPH que é fornecida pelo SUS, a parte autora junta os documentos em Evento 1, ANEXO11-16 referentes às entregas dos medicamentos.

Em Evento 33, há a juntada do PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS-FEDERAL Nº 1941/2024, sobre o medicamento e insumo Degludeca (Tresiba®) - 03 canetas/mês e o Sistema de Monitorização Contínua - leitor e sensor (FreeStyle Libre®) - 03 sensores/mês.

Decido.

O deferimento da tutela de urgência reclama o preenchimento das condições do art. 300, caput, do CPC, que impõe a presença, ao mesmo tempo, de probabilidade do direito alegado pela parte autora e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, da mesma forma que o art. 4º da Lei nº 10.259/2021, que permite, ainda, a sua concessão de ofício pelo magistrado.

Ademais, deverá ser cumprido o pressuposto específico previsto no art. 300, §3º, do CPC, no sentido de que a tutela de urgência somente será deferida quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, o laudo de Evento 1, LAUDO10, da Dra. Ana Paula Brilhante (Endocrinologista - CRM 5266782-) descreve o estado clínico da parte autora e traz a prescrição do medicamento e dos insumos Degludeca (Tresiba®) - 03 canetas/mês e o Sistema de Monitorização Contínua - leitor e sensor (FreeStyle Libre®) - 03 sensores/mês.

Encaminhados os autos ao Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde - NAT-Jus, foi juntado PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS-FEDERAL Nº 1941/2024. No documento, foram apresentadas as seguintes informações:

"Insulina de ação lenta Degludeca (Tresiba®) é uma insulina basal de ação ultralonga, indicada para o tratamento do diabetes mellitus em adultos, adolescentes e crianças acima de 01 ano. Em pacientes com diabetes mellitus tipo 1, essa insulina sempre deve ser administrada em combinação com insulina rápida ou ultrarrápida, para cobrir as necessidades de insulina prandial⁶.

O sistema de monitorização contínua de glicose (FreeStyle Libre®), se trata de tecnologia de monitoramento da glicose, composta por um sensor e um leitor. O sensor, aplicado na parte traseira superior do braço por até 14 dias, capta os níveis de glicose no sangue por meio de um microfilamento que, sob a pele e em contato com o líquido intersticial, mensura a cada minuto a glicose presente na corrente sanguínea. O leitor é escaneado sobre o sensor e mostra o valor da glicose medida. Cada escan do leitor sobre o sensor traz uma leitura de glicose atual, um histórico das últimas 8 horas e a tendência do nível de glicose. Estes dados permitem que indivíduo e os profissionais de saúde tomem decisões mais assertivas em relação ao tratamento do diabetes⁷.

Informa-se que o medicamento insulina Degludeca (Tresiba®) e o sistema de monitorização contínua de glicose - leitor e sensor (FreeStyle Libre®) estão indicados para o manejo do diabetes mellitus tipo 1, doença que acomete o Autor."

Contudo, o NAT-Jus citou a Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 17, de 12 de novembro de 2019, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da DM tipo 1. Ressaltou que o método de monitorização Free Style® Libre foi avaliado em somente um ensaio clínico, o qual mostrou que pode reduzir episódios de hipoglicemia em pacientes com diabetes mellitus tipo 1, bem controlados e habituados ao autocuidado, podendo reduzir episódios de hipoglicemia, com a ressalva de que, até o momento, não foram apresentadas evidências de benefício inequívoco para a recomendação no referido protocolo.

O NAT-Jus relatou que a referida técnica de monitorização representa um importante avanço, mas ainda é uma tecnologia em evolução, com muitos aspectos a serem aprimorados, com destaque para o fato de que o atraso de 10 a 15 minutos em relação às glicemias capilares, a possibilidade de subestimar hipoglicemias, mormente pela possibilidade de erro em torno de 15%, além de seu de alto custo financeiro e a falta de protocolos definidos para ajuste de dose de insulina com base nos resultados obtidos em tempo real.

Ademais, o NAT-Jus ressaltou que o uso do insumo não exclui a aferição da glicemia capilar (teste convencional e disponibilizado pelo SUS) em nas seguintes situações: quando ocorre rápida alteração nos níveis da glicose, para confirmar uma hipoglicemia ou uma iminente hipoglicemia registrada pelo sensor e quando os sintomas não corresponderem as leituras do sistema de monitoramento.

Segundo o NAT-Jus, apesar de o sensor para aparelho FreeStyle® Libre estar indicado para o manejo do quadro clínico da autora, não é imprescindível o seu uso, tendo em consideração o fato de que o monitoramento da glicemia pode ser feito pela forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.

Em complemento, o Nat-Jus elucidou que:

"Considerando o exposto, cumpre esclarecer que o teste de referência (tiras regentes para medição de glicemia capilar) preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (automonitorização convencional) assim como o aparelho para medir glicemia capilar (glicosímetro compatível estão padronizados para distribuição gratuita, no âmbito do SUS, objetivando o controle glicêmico dos pacientes dependentes de insulina. Para acesso aos itens ofertados pelo SUS, o Autor deve comparecer à Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, a fim de obter esclarecimentos acerca da dispensação."

Quanto a insulina Degludeca (Tresiba®), o NAT-Jus informou que o medicamento está incluído em bula para o tratamento do quadro clínico apresentado pela autora, possui registro na ANVISA, todavia, ainda não integra uma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro. Nessa toada, o parecer ainda dispõe que a insulina não se configura como alternativa neste momento:

“No âmbito da Atenção Básica, conforme relação municipal de medicamentos (REMUME) da Secretaria Municipal de Saúde, é disponibilizada a insulina NPH.

➤ *Todavia, conforme relato médico, o Autor, “... faz uso de insulina NPH fornecida pelo SUS, mas sempre com grande variabilidade glicêmica e algumas idas à emergência devido a quadro de cetoacidose diabética” (Evento 1, LAUDO10, Página 1).*

➤ *Portanto, a insulina NPH disponibilizada pelo SUS, não se configura como alternativa terapêutica neste momento.”*

Após a análise dos autos e feitas essas premissas, verifico que não estão presentes todos os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela para a dispensação do aparelho pleiteado, pois não é possível concluir acerca da imprescindibilidade do tratamento, mormente porque não foi demonstrado o esgotamento ou a ineficácia das opções terapêuticas disponibilizadas no âmbito do SUS.

Todavia, quanto ao medicamento pleiteado, resta clara a sua necessidade, sobretudo em razão da insulina NPH padronizada, disponibilizada pelo SUS, não se configurar uma opção terapêutica para aplicabilidade ao caso em tela.

Dessa forma, é manifesta a prova inequívoca do direito, bem como a plausibilidade parcial da alegação autoral, por ser dever do Estado garantir às pessoas o direito relativo à saúde, mediante acesso universal e igualitário aos procedimentos médicos e medicamentos indispensáveis para o tratamento de doenças graves, de onde deflui o fumus boni iuris.

Presentes, nesse esquadro, os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, na forma do art. 300 do CPC e de acordo com os Enunciados 51 e 92, ambos das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ, adiante transcritos:

ENUNCIADO Nº 92 Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.

ENUNCIADO Nº 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.

*Diante do exposto, **DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA** e determino que os réus, de forma solidária, forneçam à parte autora a insulina Degludeca, conforme prescrito pela médica assistente no receituário do Evento 1 LAUDO10, **em quantidade necessária inicialmente para seis meses, no prazo máximo de 20 (vinte) dias**, sob pena de multa cominatória a ser arbitrada pelo Juízo, em caso de descumprimento, devendo os réus, no mesmo prazo, comunicar ao Juízo o cumprimento da tutela ora deferida.*

*Considerando a necessidade de direcionamento do encargo financeiro em razão do sistema de repartição de competências, nos termos da tese 793 do STF e observado o enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, o **cumprimento da obrigação caberá ao Estado do Rio de Janeiro**, inicialmente, tendo em vista o referenciado no ofício Of.SES/ASSADJ Nº4595, de 19 de fevereiro de 2024, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro - SES/RJ.*

Sendo assim, malgrado o cumprimento da obrigação tenha sido direcionado ao Estado do Rio de Janeiro, inexistente empecilho para que os entes da Federação redirecionem o cumprimento entre si, de acordo com regras administrativas de repartição de competência, desde que não haja prejuízo para a parte, descumprimento da determinação judicial ou demora injustificada na sua implementação.

O medicamento deverá ser disponibilizados à parte autora, ficando a entrega para os semestres seguintes, condicionada à apresentação de receituário médico atualizado.

A prescrição médica deverá observar o Enunciado nº 15 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, in verbis:

As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional - DCI, o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante a justificativa técnica.

Os réus deverão informar nos autos a data e o local em que serão disponibilizados os insumos à parte autora.

*Na hipótese de bloqueio das verbas através do **SISBAJUD**, a parte autora deverá juntar nos autos, no prazo de 20 dias, cópias (legíveis e não repetidas) das notas fiscais comprovando a aquisição dos insumos, sob pena de remessa de peças ao Ministério Público para adoção das providências cabíveis*

A parte autora deve informar ao juízo eventual descumprimento desta decisão, e, nesse caso, fica obrigada a juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, três orçamentos a fim de possibilitar a aquisição.

Deve a parte autora, ainda, efetuar o seu cadastro na Coordenaria do Município de Atendimento de Mandado (Estrada dos Bandeirantes, nº 1700, Lote 02 - Galpão 01 - Armazéns 109 a 119, Taquara, Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ), bem como na Central de Atendimento a Demandas Judicial do Estado (Rua México, nº 128 - Centro - Rio de Janeiro/RJ).

Fique ciente a parte autora de que deverá manter contato permanente com as Centrais através dos telefones 3432-4489, 3432-4863 ou 3432-4591 (Central do Município) e 23320988 ou 23320956 (Central do Estado).

Determino a intimação dos réus através do e-Proc, no modo URGENTE, para efetivo cumprimento desta decisão, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme acima determinado, devendo os representantes dos Entes Públicos fazer contato diretamente com o paciente, nos telefones de contato constantes nos autos (petição inicial).

Citem-se as partes rés para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem contestação, nos do art. 9º da Lei nº 10.259/2001, e do parágrafo 4º do art. 11 do Provimento nº 02/2002 da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região. Na oportunidade, deverão ainda apresentar toda a documentação de que disponham para o esclarecimento da lide, tudo nos termos do caput do art. 11 da Lei nº 10.259/2001, bem como verificar se há prevenção, conforme dispõe o art. 337, VI, VII e VIII, do CPC.

Intimem-se.

Sustenta o recorrente que apresenta diabetes Mellitus tipo 1 de muito difícil controle (CID - E10) desde os 18 (dezoito) anos e vem tentando controlar intensivamente suas taxas nos últimos anos, mas sempre com grande variabilidade glicêmica e idas ao pronto socorro. Portanto, o Recorrente, ainda que tenha utilizado as terapias disponibilizadas pelo SUS, não logra êxito no controle de sua doença. Com base no relatório médico anexado à inicial, constata-se que o paciente atualmente utiliza insulina NPH, sendo este insumo padronizado na lista do SUS. Aponta que a médica que o acompanha, Dra. Ana Paula Brilhante, CRM: 5266782-0, atestou: *“Paciente Filipe Navarro Brasil com diagnóstico de diabetes tipo 1 desde os 18 anos. Faz uso de insulina NPH fornecida pelo SUS, mas sempre com grande variabilidade glicêmica e algumas idas ao pronto socorro devido a quadro de cetoacidose diabética. Em virtude de já ter feito vários esquemas com a insulina fornecida pelo SUS (NPH) e não ter conseguido controle da sua glicemia, solicito insulina degludeca (Tresiba), onde fará 30 UI por dia, ou seja, precisará de 3 canetas mensais. Além disso, apresenta indicação de uso de sensor em virtude de possuir grande variabilidade glicêmica e hipoglicemias frequentes.”*

Sem contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, a preservação da saúde é dever genérico solidário de todas as entidades federativas (art. 23, II e 196, CF/88). No entanto, as atribuições públicas específicas no campo da saúde, são descentralizadas, sendo a responsabilidade limitada à própria esfera de atribuições definidas em lei, conforme dispõem os art. 197 e 200 CF/88.

Nesse particular, descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços de saúde são diretrizes básicas e princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde – SUS:

“Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo.” (grifo nosso)”

Regulamentando essa disposição constitucional e com ênfase especial à descentralização dos serviços, preceito inserido no art. 198, I CF/88, foram editadas as Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e 8.142/90 (financiamento do SUS), além de inúmeras outras normas infraconstitucionais.

Nesse particular, é clara a Lei 8.080/90 quando determina a descentralização de medidas com ênfase para os municípios, conforme:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;(...)

Destarte, fica evidente que as responsabilidades quanto à execução das ações finalísticas de prestação de serviços de saúde, dividem-se entre a União, os Estados e os Municípios, cada um dentro de suas respectivas esferas de atribuição, devendo-se ressaltar aqui, que à União compete basicamente a formulação de políticas nacionais, financiamento do Sistema, com o repasse de verbas próprias a Estados e Municípios, sendo que a estes últimos ficaria a principal atribuição de prestar o atendimento ao cidadão, especialmente no campo do fornecimento de medicamentos.

No caso, a parte autora já se encontra sob o manto da tutela antecipada estatal, visto que o Juízo a quo já deferiu o tratamento requerido, apenas deixando a medida da glicose de forma convencional, ao menos, no presente momento. Porém, inconformada com a decisão, a parte autora objetiva o fornecimento, em liminar, dos insumos 1 (um) monitor Frees Style Libre e 3 (três) sensores por mês e, na quantidade e prazo determinados por médico responsável.

Conforme Parecer do NAT, evento 33 dos autos principais, o sistema de monitorização contínua da glicose – monitor e sensores (FreeStyle® Libre), apesar de estar indicado, para o manejo do quadro clínico da autora, não é imprescindível; e não configura item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.

Ainda que sua médica indique o aparelho como a melhor forma e mais moderna de medida da glicose, não é a única forma, sendo certo que, ao menos, em sede de tutela de antecipada, deve ser garantido o direito à vida, mediante o tratamento já concedido pelo Juízo a quo.

Para a obtenção da tutela, enquanto modalidade de tutela de urgência, a parte autora deve demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria manifestação final do Poder Judiciário. E isso somente pode acontecer quando efetivamente ocorrer o risco de perecimento e destruição, desvio, deterioração ou qualquer tipo de alteração no estado das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficiente atuação do provimento final de mérito. Equivale neste ponto, ao denominado *periculum in mora*, ventilado em sede de tutela cautelar.

No caso em apreço, contudo, entendo não estarem presentes os requisitos supracitados, cuja demonstração, de pronto, é necessária para que ocorra o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, em caráter liminar.

Em verdade, a parte autora não demonstra, de plano, o “*perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo*”, que fundamente uma decisão *in limine*, sem que seja deferido, primeiramente, o contraditório à parte adversa, na medida em que o pedido liminar configura uma tutela satisfativa, sendo que sua concessão sem a prévia manifestação da parte ré somente se justifica quando a urgência indicar a necessidade de concessão imediata, o que não se afigura na espécie.

Já a prova inequívoca apta a demonstrar a verossimilhança da alegação exige análise detalhada dos documentos anexados à inicial em harmonia com os fundamentos da parte autora, bem como, o cotejo dos fatos e provas trazidas pelos réus.

Portanto, em sede de cognição perfunctória, entende-se que os documentos apresentados pela parte autora não se mostram aptos a demonstrar a plausibilidade dos pontos de fato e de direito que enseje a antecipação dos efeitos da tutela *in limine*.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.

